

CAPÍTULO 13.25

Manejo de la Crisis Asmática

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El manejo de la **Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)** se divide fundamentalmente en dos pilares: intervenciones que **aumentan la sobrevida** (modifican el pronóstico de la enfermedad) e intervenciones destinadas al **alivio de síntomas** (mejoran la calidad de vida). A diferencia del **Asma**, el EPOC es una enfermedad progresiva donde el cese del daño es el objetivo primordial.

Medidas que aumentan la Sobrevida

Estas son las intervenciones más críticas, ya que son las únicas capaces de alterar la historia natural de la enfermedad y reducir la mortalidad.

1. Cese del Hábito Tabáquico

Es la medida más importante y con mayor impacto demostrado. Dejar de fumar detiene la caída acelerada del **VEF1** (volumen espiratorio forzado en el primer segundo), logrando que el deterioro del parénquima pulmonar se asemeje más al envejecimiento fisiológico normal.

2. Oxigenoterapia Domiciliar de Largo Plazo (ODLP)

El oxígeno no se indica a todos los pacientes, sino a aquellos que presentan **insuficiencia respiratoria crónica**. Se debe usar la mayor cantidad de horas posible (idealmente >15-18 horas al día).

Criterios de indicación de Oxígeno: Se define por gases en sangre arterial (GSA) en reposo, aire ambiental y paciente estable:

TABLA 13.25.1: ESCENARIO CLÍNICO VS CRITERIO DE PRESIÓN DE OXÍGENO (PAO2)

ESCENARIO CLÍNICO	CRITERIO DE PRESIÓN DE OXÍGENO (PAO2)	OTROS HALLAZGOS
Escenario A	PaO2 < 55 mmHg	Independiente de otras complicaciones.
Escenario B	PaO2 entre 55 y 60 mmHg	Presencia de Cor Pulmonale (falla derecha), Hipertensión Pulmonar o Poliglobulia (Hto > 55%).

NOTA CLÍNICA

La hipoxemia crónica genera vasoconstricción pulmonar refleja, lo que deriva en hipertensión pulmonar y, finalmente, en insuficiencia cardíaca derecha (Cor Pulmonale). El oxígeno rompe este ciclo fisiopatológico.

3. Rehabilitación Pulmonar

Consiste en un programa multidisciplinario que incluye kinesiología respiratoria, ejercicios de fortalecimiento de la musculatura accesoria y aumento de la actividad física. - **Beneficio:** Mejora la mecánica ventilatoria, aumenta la tolerancia al ejercicio y disminuye la disnea. - **Sobrevida:** Aunque hay debate, estudios recientes sugieren que podría tener un impacto positivo en la mortalidad, especialmente tras una exacerbación.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En pacientes que no cumplen criterios de ODLP en reposo pero desaturan significativamente durante el ejercicio (PaO2 < 55-60 mmHg), se recomienda el uso de **oxígeno durante el esfuerzo** para mejorar la capacidad física y la calidad de vida.

Manejo Farmacológico de los Síntomas

El tratamiento farmacológico en el EPOC es escalonado. A diferencia del **Asma**, los broncodilatadores son el eje central y los corticoides inhalados quedan relegados a etapas avanzadas.

Primera Línea: Broncodilatadores de Acción Corta (SOS)

Se utilizan para el rescate ante síntomas agudos. - **SABA:** Salbutamol. - **SAMA:** Bromuro de Ipratropio. - **Combinación:** Es frecuente dejar ambos (Salbutamol + Ipratropio) para potenciar el efecto broncodilatador con menores dosis de cada uno.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En pacientes **cardiópatas** o con antecedentes de arritmias, se debe preferir el uso de **Ipratropio** o limitar el Salbutamol, ya que este último puede gatillar taquicardia, temblor y arritmias debido a su efecto pro-adrenérgico.

Segunda Línea: Broncodilatadores de Acción Larga

Son el tratamiento de mantención para pacientes que presentan síntomas de forma frecuente. - **LABA:** Formoterol, Salmeterol (cada 12 horas). - **LAMA:** Tiotropio (generalmente cada 24 horas). Los anticolinérgicos de acción larga tienen una excelente respuesta en pacientes con EPOC.

Tercera Línea: Corticoides Inhalados (CI)

A diferencia del **Asma**, los corticoides inhalados (Fluticasona, Budesonida, Mometasona) **no aumentan la sobrevida** en el EPOC. - Se indican en pacientes con exacerbaciones frecuentes o síntomas persistentes a pesar de un esquema óptimo con LABA/LAMA. - Se deben usar siempre de forma reglada (cada 12 horas). - **Prueba terapéutica:** Si tras indicarlos no hay mejoría clínica evidente, se recomienda suspenderlos para evitar efectos adversos (como neumonía o candidiasis oral).

Inmunizaciones (Vacunación)

Todo paciente con EPOC debe mantener su calendario de vacunación al día para prevenir exacerbaciones infecciosas:

- **Influenza:** Vacunación anual (cada invierno).
- **Neumococo:** Vacunación (habitualmente esquema cada 5 años o según norma vigente). Previene neumonías bacteriémicas.
- **COVID-19:** Refuerzos según indicación de la autoridad sanitaria (probablemente anual).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Pregunta clásica de examen: ¿Cuál es la medida que más reduce la mortalidad en un paciente con EPOC? **Respuesta: Cese del hábito tabáquico.** Si el paciente ya tiene insuficiencia respiratoria, la respuesta es **Oxigenoterapia domiciliaria.**

Resumen de Diferencias con el Asma

Es vital no confundir el manejo de ambas patologías obstructivas:

- En el **Asma**, los **Corticoides Inhalados** son la primera línea de mantención y disminuyen la mortalidad.
- En el **EPOC**, los **Broncodilatadores** (LAMA/LABA) son la base del tratamiento y los corticoides son solo para síntomas en etapas avanzadas.
- El EPOC se asocia fuertemente al tabaco; el asma tiene un componente atópico/alérgico más marcado.

Insuficiencia Respiratoria Oxigenoterapia Tabaquismo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 30 años, asmático conocido, llega a urgencias con disnea, sibilancias difusas y saturación de 91%. Se administra oxígeno y salbutamol 2 puf cada 20 minutos por 1 hora. Al reevaluar, el PEF es 65% del teórico. ¿Cuál es la conducta más apropiada respecto a los corticoides?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo de la Crisis Asmática. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Tres pilares: oxígeno (si sat <93%, titular 93-95%), salbutamol en puf (2-4 puf cada 10-20 min por 1 hora) y corticoides sistémicos.
- El salbutamol en puf con aerocámara es de elección sobre las nebulizaciones.
- Alternativas al salbutamol: formoterol en puf (inicio rápido) o nebulizaciones cada 20 min.
- Corticoides sistémicos (no inhalados) cuando PEF <80% o clínica grave: prednisona 20-40 mg/día VO por 5 días.
- Sin neumonía no se indican antibióticos en la crisis asmática.
- Hospitalizar si: PEF <50% sin mejoría, sat <90%, taquipnea >30, disnea de reposo, compromiso de conciencia o agotamiento muscular.
- También hospitalizar si: corticoides orales en domicilio, paro previo, VM reciente o múltiples hospitalizaciones.
- Los gases arteriales se reservan para crisis severas, no se piden rutinariamente.
- Educar sobre adherencia al tratamiento, evitación de desencadenantes y automanejo de crisis leves en domicilio.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DE LA CRISIS ASMÁTICA)**PREGUNTA 1**

Paciente de 30 años, asmático conocido, llega a urgencias con disnea, sibilancias difusas y saturación de 91%. Se administra oxígeno y salbutamol 2 puf cada 20 minutos por 1 hora. Al reevaluar, el PEF es 65% del teórico. ¿Cuál es la conducta más apropiada respecto a los corticoides?

- A)** No indicar corticoides ya que el PEF está sobre 50%.
- B)** Indicar corticoides inhalados en dosis alta.
- C)** Indicar prednisona 20-40 mg/día vía oral por 5 días.
- D)** Indicar hidrocortisona endovenosa en bolo único.
- E)** Indicar corticoides solo si no mejora en las próximas 2 horas.

PREGUNTA 2

Paciente asmática de 25 años llega a urgencias con crisis asmática. Tras 1 hora de tratamiento con salbutamol y corticoides, el PEF es 45% y persiste con disnea de reposo, solo puede decir palabras entrecortadas, frecuencia respiratoria de 32/min y saturación de 88%. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Dar alta con prednisona oral y control ambulatorio en 48 horas.
- B)** Continuar salbutamol cada 20 minutos por 1 hora más y reevaluar.
- C)** Hospitalizar por crisis grave que no mejora.
- D)** Agregar antibióticos empíricos y dar alta.
- E)** Nebulizar con adrenalina y observar por 30 minutos.

PREGUNTA 3

Paciente de 40 años, asmático, consulta en urgencias por exacerbación asmática. Refiere que en su casa usa corticoides orales diariamente como parte de su tratamiento crónico. La crisis actual es de severidad moderada y mejora parcialmente con el tratamiento. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Dar alta con aumento de dosis de corticoides orales.
- B)** Hospitalizar al menos 24 horas dado el antecedente de corticoides orales crónicos.
- C)** Dar alta con salbutamol SOS y control en 72 horas.
- D)** Dar alta sin modificar tratamiento ya que mejoró parcialmente.
- E)** Indicar fármacos biológicos y dar alta.

RESUMEN: MANEJO DE LA CRISIS ASMÁTICA

La crisis asmática es una emergencia que todo médico general debe saber manejar con precisión, incluyendo dosis y tiempos. Los tres pilares del tratamiento son: oxígeno (si saturación <93%, titular entre 93-95%, sin miedo a diferencia del EPOC), salbutamol (fármaco que resuelve la crisis aguda) y corticoides sistémicos (aumentan sobrevida y previenen recurrencias). El salbutamol se administra de elección en puf con aerocámara (2-4 puf cada 10-20 minutos por 1 hora); como alternativas se puede usar formoterol en puf o nebulizaciones cada 20 minutos por 1 hora. Los corticoides se indican cuando la crisis tiene gravedad (PEF <80% o clínica severa) y deben ser sistémicos, no inhalados (los inhalados son para el manejo crónico). La vía más frecuente es oral (prednisona 20-40 mg/día por 5 días); si no tolera vía oral, se usa endovenosa o intramuscular. Como alternativa oral está la dexametasona o betametasona. Es fundamental buscar la causa desencadenante (neumonía requiere antibióticos, pero sin neumonía no van antibióticos en asma) y educar sobre adherencia, desencadenantes y automanejo de crisis en casa. La hospitalización se indica en crisis grave que no mejora (PEF <50% sin mejoría), taquipnea >30/min, saturación <90% (PaO₂ ~60 mmHg), disnea de reposo con frases cortas o palabras entrecortadas, compromiso de conciencia, agotamiento muscular, o crisis moderada sin mejoría tras 1-2 horas. También se hospitaliza ante antecedentes de alto riesgo: uso de corticoides orales en domicilio, paro cardiorrespiratorio previo, ventilación mecánica reciente o múltiples hospitalizaciones. Los gases arteriales no se piden rutinariamente, pero sí en crisis severas para evaluar insuficiencia respiratoria.